

52 - 01-les anomalies de la muqueuse buccale du palais - Pr. MANSOURI

(0:02 - 0:24)

Nous allons approcher à notre dernier cours, donc le cours 7 de cette série de cours de sémiologie de chirurgie maxillofaciale qui est intitulé les anomalies de la muqueuse buccale et du palais. Donc c'est un autre type de sémiologie, un autre type de symptomatologie clinique. Nous allons être dans la cavité buccale et nous allons travailler dans la cavité buccale.

(0:26 - 0:49)

En guise d'introduction, il y a d'abord des aspects cliniques très variés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver en examinant une cavité buccale et beaucoup de choses derrière lesquelles va s'exprimer le patient et motiver sa consultation. Les étiologies sont multiples, il y a des pathologies locales et des pathologies générales et des signes révélateurs.

(0:52 - 2:08)

Alors deux types d'anomalies existent, donc il y a les anomalies locales et les infections locales et les anomalies par infections générales, donc locales, télémalformations, les infections, les traumatismes et les tumeurs. Puis les anomalies par infections générales, les troubles endocriniens, carenciels, intoxication et les maladies dermatologiques. Donc vous voyez qu'il y a un panorama énorme d'anomalies qui peuvent s'exprimer au niveau de la cavité buccale.

Et bien pour faire le diagnostic comme partout, on fait d'abord une démarche de diagnostic, un examen clinique et des examens complémentaires, ondo-buccal, exo-buccal, passant par l'inspection et la palpation et l'interrogatoire, évidemment. Alors on cherche aussi un type de douleur, saignement gingival, le mot de début, s'il y a une récurrence, donc s'il y a une répétition, c'est ça la récurrence, c'est la répétition. On cherche des antécédents mais on fait aussi des examens biologiques NFS, l'examen anapath donc histopathologique, quand on prélève un petit morceau d'une lésion bien sûr, on peut l'examiner pour voir le type histologique et puis il y a l'examen bactériologique et mycologique.

(2:11 - 2:21)

Quelles sont ces anomalies ? Elles sont au nombre de cinq. D'abord les anomalies de la mycose. Donc vous savez que dans la cavité buccale, il y a plusieurs secteurs et plusieurs régions et plusieurs tissus.

(2:21 - 3:14)

On commence par le tissu muqueux. C'est quoi la mycose ? C'est tout le revêtement rouge que vous voyez dans une bouche qui est mou dans les joues et qui est dur à côté des dents et qui

devient une gencive. On commence par l'étuméfaction.

Donc l'étuméfaction, c'est un aspect de gonflement circonscrit ou diffus. L'étuméfaction, c'est toujours un gonflement, c'est une augmentation du volume d'une région ou d'un organe. Et là, au niveau de la cavité buccale, vous voyez, si on va réfléchir du bas vers le haut, il y a cette étuméfaction au niveau de la lèvre inférieure, cette augmentation du volume diffuse de toute la lèvre inférieure, cette augmentation du volume du palais et la face interne de la joue.

C'est une voussure. C'est une voussure. Regardez-moi les voussures.

(3:16 - 9:51)

Donc, c'est un aspect de gonflement circonscrit ou diffus qui peut être d'origine inflammatoire qui se manifeste par un oedème. Par exemple, sur cette image, on a ce qu'on appelle l'oedème de cuir qui est d'origine allergique. Par exemple, vous consommez une alimentation allergique, vous vous faites piquer par un insecte ou bien des fois on met des produits cosmétiques qui ne sont pas de bonne qualité, ils peuvent créer une augmentation du volume de la lèvre et puis ça gratte, c'est trop vigineux et nous avons un oedème qui peut s'étendre jusqu'à la base de la langue.

Nous avons les tumeurs. Par exemple, ici, au niveau du palais, il y a des tumeurs. Regardez-moi, c'est une augmentation du volume des voussures au niveau gingival.

Il y a aussi les malformations vasculaires. Donc, les malformations vasculaires, le cas de ce qu'on voit sur la lèvre ici, c'est ce qu'on appelle un angium qui est bleuté, qui est de consistance moelle, qui va s'affaïsser à la pression. Quand on va appuyer sur la lèvre, elle se vide parce qu'elle est remplie de vaisseaux et de sang.

Et l'augment de taille aussi en position d'éclive, ça veut dire quand cet enfant va s'allonger, la tumeur va se vider de son sang. Et puis, on peut avoir même un souffle à l'auscultation. Comme c'est vasculaire, ici c'est une malformation artérielle.

On va mettre le stéthoscope sur cette malformation et on va écouter un souffle, le souffle de passage de sang dans cette tuméfaction. Donc là, c'est juste, on refait, c'est la même chose. Donc, c'est la tuméfaction d'origine vasculaire.

Et puis, on part après les tuméfactions, les anomalies de la pigmentation. Donc, une muqueuse soit peut-être siège d'une tuméfaction, donc d'une augmentation du volume, mais elle peut être aussi le siège d'une anomalie de pigmentation. Ça veut dire quoi la pigmentation ? La pigmentation, c'est la coloration.

Ça veut dire qu'elle peut changer de couleur dans le sens trigrand de pigmentation, hyperpigmentation ou hypopigmentation ou carrément changement de couleur. Ça peut être même dans la couleur blanche ou noire. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de sémiologie et en termes médicaux ? Et comment on va l'exprimer quand le patient vient nous voir ? On ne

va pas dire ça c'est une tâche noire, c'est une tâche blanche.

Voilà ce qu'on va dire. Eh bien, on va avoir soit une classification des hyperpigmentations. Les hyperpigmentations, ça veut dire l'accentuation de la coloration de la muqueuse.

Soit, nous allons avoir les tâches brunes, donc c'est brun, c'est foncé et cela est très péjoratif. C'est même grave. Ça peut être un cancer.

Quand on ouvre une bouche et on trouve qu'il y a quelque chose de noir ou de foncé, il faut penser au mélanome qui est un cancer. Tâche brune ou noire, un peu surélevée, indolore de la gencive et du palais chez un sujet âgé. Donc une tâche brune, ça peut être d'origine carcinologique.

Les tâches brunes aussi peuvent signifier une maladie générale telle par exemple l'insuffisance surrénalienne. C'est les tâches brunes de la maladie d'Addison. Comme vous voyez ici, regardez la gencive avec des tâches.

Il y a des zones qui sont sombres. Regardez là, il y a cette tâche sombre. Mais on peut avoir aussi une autre pathologie, c'est le névus bénin.

Donc si je pose la question, par exemple, un QCM ou jamais, vous recevez à la consultation un patient de 60 ans qui présente une tâche brune au niveau du palais et je vous mets comme énumération de réponses, premièrement le mélanome, deuxièmement tâche brune de la maladie d'Addison, troisièmement le névus et je rajoute autre chose à vert, nous allons cocher mélanome, tâche brune et névus bénin et le reste c'est faux. Toujours les hyperpigmentations syndrome de Peutz-Jegers. Ce syndrome, c'est une affection héréditaire avec des tâches brunes de la labiale mais qui accompagne une polypose digestif aussi.

Un syndrome, c'est un ensemble de signes qui sont constants et qui déterminent une entité. Et le syndrome de Peutz-Jegers, il constitue une entité avec polypose, donc des polypes dans le tube digestif et ces tâches que vous voyez ici brunes comme du tatouage. Une autre cause, comme vous voyez ici sur la photo, regardez-moi cette gencive qui est très foncée.

C'est les intoxications au plan de saturnisme. Les ouvriers qui travaillent dans des ambiances où il y a du plan de l'arsenic ou de l'argent vont montrer des gencives qui deviennent sombres. Il y a aussi des carences en vitamine, en vitamine PP, en vitamine C. Il y a aussi les hémochromatoses, donc les surcharges en fer ou les suroses hépatiques.

Donc il y a finalement beaucoup de causes de l'hyperpigmentation et beaucoup de types d'hyperpigmentation, donc vous devez les retenir. Toujours dans les tâches hyperpigmentées, nous avons vu les tâches brunes et là on va parler de tâches bleues. Pour les tâches bleues, c'est dominé d'une manière générale par deux causes.

Les malformations veineuses, regardez-moi là, c'est une malformation veineuse, c'est une malformation veineuse. Et puis il y a la cyanose, donc vous pouvez avoir des lèvres et une

langue qui sont bleues. Il y a des patients qui ont une insuffisance respiratoire, donc ils sont mal oxygénés, soit chroniques, soit aigus ou bien des insuffisances cardiaques, donc cardiopathie ou bronchopneuropathie et qui vont manifester la couleur bleue au niveau des lèvres et au niveau de la langue, c'est de la cyanose.

Sinon les tâches bleues circonscrites, d'une manière générale, c'est des tâches d'origine veineuse, donc vasculaire. Nous avons aussi les lésions érythémateuses, donc nous avons vu les tumefactions, nous avons vu les hyperpigmentations, ça veut dire l'augmentation de la coloration et le changement et nous avons vu les tâches brunes et les tâches bleues. Et puis là, on va voir les lésions érythémateuses.

(9:52 - 10:25)

Ça veut dire quoi érythémateuses ? Ça veut dire des lésions qui sont rouges. Et là, on a les lésions rouges, congestives, comme ce que vous voyez sur cette image et sur cette image, qui peuvent être d'origine inflammatoire, qui peuvent être d'origine lésionnelle, telle l'érythroplasie de carotte et le carcinome épidermoïde. Ça peut être d'origine allergique, la radiomucite, donc après radiothérapie.

(10:25 - 11:04)

Ça peut être aussi une infection bactérienne, candidosique ou virale. Donc là, les causes des lésions érythémateuses, donc des lésions rouges qui peuvent apparaître dans une bouche, ça résume ce qu'on vient de voir ici. Soit c'est une inflammation, soit c'est un état précancéreux.

De toutes les façons, toute lésion rouge qui apparaît dans la bouche doit faire suspecter d'abord un cancer. Et ensuite, elle élimine le reste. Toute lésion anormale dans une cavité buccale et qui traîne et qui ne disparaît pas au bout d'une semaine à deux semaines, il faut se poser la question si ce n'est pas un cancer.

(11:06 - 20:04)

Il y a aussi les lésions blanches. Donc, nous avons vu les lésions érythémateuses et les rouges et il y a les lésions blanches. Dans la bouche, les lésions blanches, c'est comme du lait, c'est comme du caillot.

Là, regardez sur la langue et sur les lèvres, ça apparaît comme des croûtes blanchâtres. C'est comme des dépôts de lait blanc et de fromage sur la bouche, ce sont les lésions. La grande cause, c'est les candidoses aiguës.

Donc, les candidoses aiguës sont en forme de plaques blanchâtres qui se décollent facilement avec des signes de brûlure et ça survient chez les diabétiques parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'immunité ou bien les gens qui prennent beaucoup d'antibiotiques, surtout chez les enfants. Nous avons les candidoses chroniques. Regardez-moi cette plaque géographique en orobuccale, il n'y a pas de rougeur à côté, elle est chronique, elle est

ancienne, elle ne se décolle pas comme la candidose aiguë, elle est indolore et dans ce cas, c'est une... elle fait le lit du cancer, elle peut se transformer en cancer.

Et toujours comme les lésions blanches ou ce qu'on appelle aussi l'eucoplasie, nous avons les hyperkeratinisations. Ça veut dire le développement excessif du tissu muqueux sur la plaque ou sur la surface de la muqueuse avec un développement important de couches cornées, de l'épiderme et des plaques blanchâtres ou épaisses. Là aussi, ces hyperkeratinisations, telle l'eucoplasie tabagique des chikors de nefs, fait le lit au cancer.

C'est un état pré-cancéreux. Le lichen blanc, donc c'est la quatrième lésion blanche, c'est des lésions muqueuses isolées ou associées à des lésions cutanées. Regardez, elle est en plaque géographique sur une muqueuse jugale d'une manière générale.

Divers aspects réticulés ou en plaques. Il y a de la douleur, pas très importante mais elle existe. Elle évolue en chronique et elle peut se transformer aussi en cancer.

Donc nous avons vu, à part la candidose aiguë, toutes les autres lésions peuvent se transformer en cancer. La papillomatose orale floride, donc la cinquième lésion, qui est un état pré-cancéreux, c'est une lésion pré-cancéreuse, elle a un aspect enchouffleur. Regardez-moi ça, c'est une lésion enchouffleur.

C'est une lésion au papillomavirus avec un aspect enchouffleur et c'est un état pré-cancéreux. Il y a l'hyperkeratose du carcinome épidermoïde, aussi bien différenciée, qui est ulcéro-bourgeonnante. Et cette hyperkeratose, regardez-moi au niveau de la base de la langue, c'est un état de carcinome épidermoïde.

Donc vous le voyez, vous n'allez pas dire que c'est de la candidose chronique. Pensez au cancer. Je reviens pour dire que toute lésion dans la bouche, qu'elle soit blanche ou rouge ou hyperpigmentée, elle doit toujours d'abord faire éliminer un cancer.

Surtout si elle dure, une lésion qui apparaît récemment et qu'au bout d'une semaine ou deux semaines, elle disparaît, c'est bénin. Mais quand elle persiste, au bout d'un mois qu'elle est là, il faut biopsier et il faut faire une biopsie. Et envoyer un morceau de la lésion, on va le prendre sous anesthésie locale et on l'envoie pour faire l'examen histopathologique et voir si ce n'est pas un cancer.

Les ulcérations, donc nous avons des ulcérations, comme ce que vous voyez ici sur la langue, qui sont des pertes de substances et une partie de la muqueuse qui part au niveau de la cavité vocale. Elle peut être d'origine traumatique, et là c'est très classique. Et quand vous avez une fracture de la dent, elle va blesser la langue et elle va créer une ulcération traumatique.

Généralement, elle disparaît très vite. Par contre, les ulcérations qui durent dans le temps et qui sont à bord irrégulier, surélevées, avec un fond bourgeonnant et qui saignent au contact et qui est endurée à la palpation, c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Et ça c'est une question qui risque de se poser sans problème.

Une ulcération chez un patient ou une patiente de 50 ans et qui est à bord irrégulier, surélevée, forme bourgeonnant et saigne au contact et endurant, cancer, hyperplasie, hyperkeratose, etc. c'est un cancer. Ou bien le contraire.

Signe de malignité d'une lésion, ils sont à bord irrégulier, surélevée, fond bourgeonnant, saignement au contact et induration à la palpation. Donc là aussi, c'est une question qui risque d'être ajoutée. Les ulcérations, il y a aussi les carcinomes épidermoïdes de la lèvre.

Regardez là ici, là c'est tout simplement un cancer. Bord saillant, c'est des lésions qui sont dues à l'infiltration des tissus par les cellules. Vous avez aussi les causes infectieuses à germes banals, par exemple là c'est une infection aiguë, ou à germes spécifiques comme la syphilis.

Là c'est une ulcération d'origine syphilitique et là bien sûr la biologie permet de l'éliminer sans aucun problème aux explorations. Là c'est toujours l'ulcération infectieuse et là on voit le chancre syphilitique chez ce patient, donc c'est une lésion typique de la syphilis. Les aftes aussi, ça existe, mais les aftes c'est une infection bénigne, superficielle, aiguë, qui survient en coup d'ongle, très vite, douloureuse, à fond jaunâtre, qui dure cinq à dix jours et qui paraît qu'il y a une guérison spontanée, mais qui peut revenir.

Et donc on ne peut pas parler de cancer. Une ulcération qui disparaît au bout de dix jours et qui peut disparaître à quinze jours, ça ne peut pas être un cancer, c'est une lésion qui est bénigne. Il y a aussi l'aphtose, comme les aftes, l'aphtose bipolaire qui rentre dans le cadre de la maladie de Bassett, ça veut dire buccale et génital.

C'est pour cela que toutes aftes qui durent dans le temps et qui persistent, qui reviennent souvent, il faut examiner le patient, surtout au niveau génital, à la recherche d'une deuxième localisation pour éliminer la maladie de Bassett. Donc après les lésions ulcéreuses, nous avons les lésions fissuraires. Fissuraires c'est quoi, regardez ici au niveau de la commissure, fissure, c'est une ulcération linéaire et profonde touchant l'épiderme et le derme.

Elle siège dans les plaies muqueuses, dans les commissures labiales et le plancher buccal. La cause la plus fréquente c'est l'éperlèche, donc c'est d'origine infectieuse, surtout mycosique, candidosique, mais une ulcération surtout chez le sujet relativement âgé qui persiste et qui ne disparaît pas, elle doit faire chercher le cancer et surtout le carcinome épidermique. Les lésions vésiculaires, ce sont des vésicules comme vous voyez, on dirait des grappes de raisins, donc ils peuvent être soit infradermiques et qui sont sur la face, mais ils peuvent aussi être au niveau de la cavité buccale, regardez ici, on les voit au niveau de l'alluette et ce sont des vésicules qui vont se remplir et laisser des ulcérations très superficielles.

L'origine virale, herpès, zona, mais aussi les eczémas bien évidemment. Les lésions bulleuses, c'est sous forme de bulles, regardez-moi ces bulles ici, sous forme de flicains, c'est le soulèvement épidermique renforçant, renfermant un liquide séreux et qui va entraîner des flicains, des ulcérations. Les causes, c'est les dermatoses, le pinficus et les ritines polymores.

Donc vous voyez ici le poignet, la deuxième localisation de l'érythème polymorphe qui intéresse non seulement les lèvres, mais aussi la peau au niveau de l'avant-bras. Les anomalies particulières de la langue, là aussi c'est important, une langue peut être dépapillée. C'est quoi dépapillée ? Eh bien on va revenir à la normale, la langue normalement est papillée, elle est pourvue de papilles et donc elle n'est pas lisse, elle est rugueuse, elle peut être dépapillée, donc atrophique, regardez cette langue qui brille, qui est trop lisse et qui est très douloureuse.

La cause ce sont les malnutritions, les anémies de bière mère, les anémies par carence en fer. La langue aussi peut être hyper papillée, ça veut dire qu'elle va développer beaucoup les papilles, elle va devenir veloutée, comme du vélo, comme un tapis. Et là la cause la plus fréquente c'est les condyldoses et le tabagisme.

(20:05 - 22:49)

La langue hyper papillée, la langue plicaturée, donc est fissurée, c'est ce qu'on appelle la langue scrotal. La macroglossie, on peut avoir une énorme langue, elle peut être constitutionnelle, génétique, il y a des gens qui naissent avec une grande langue, grosse et grande langue, mais elle peut être aussi suite à des maladies de surcharge, l'hypothyroïdie, et aussi un aspect de pseudo tumeur. Donc la macroglossie, c'est une augmentation du volume de la langue, c'est une définition que vous voudrez que vous connaissiez, que vous maîtrisez.

C'est quoi une macroglossie, macroglossie c'est l'augmentation du volume de la lèvre et macroglossie c'est une augmentation du volume de la langue. Les anomalies des lèvres, et bien la lèvre peut être siège d'une anomalie et l'anomalie la plus connue, dont on la connaît, c'est la fente, la fente labiale, la fente labio-alvéolaire, la fente labio-alvéolaire bilatérale cette fois-ci au lieu qu'elle soit unilatérale, c'est une malformation congénitale par défaut de fusion des bourgeons faciaux, c'est une solution de continuité de la lèvre, elle peut être isolée ou associée à une fente palatine. Donc la définition de la fente labiale, c'est une malformation congénitale par défaut de fusion des bourgeons faciaux.

Donc c'est une malformation congénitale, c'est très important à savoir. Toujours les malformations labiales, la macroglossie, on a parlé de macroglossie, là c'est une macroglossie, ça veut dire une lèvre qui est très augmentée de volume, donc les lèvres qui sont grosses, qui sont énormes. D'ailleurs maintenant, en médecine esthétique, les gens se mettent à augmenter le volume de leurs lèvres pour donner du volume, pour donner de la forme.

Ce ne sont pas des macroglossies, mais des fois il y a une exagération dans ce sens et on trouve carrément des macroglossies esthétiques. La macroglossie peut être congénitale, donc il y a des lèvres qui sont énormes naturellement, donc en chirurgie esthétique et en maxillofacial, on les réduit et on les rend dans l'harmonie. Et il y a aussi des duplications labiales, comme ce patient, donc il a double lèvre, regardez-moi, deux lèvres.

C'est malformatif, c'est une augmentation de la taille des lèvres, surtout la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Donc c'est des maladies inflammatoires, de surcharge, mais ça peut être aussi

tout simplement congénitale. Les anomalies de l'incive, donc on peut avoir une hypertrophie gingivale d'origine congénitale, hormonale, iatrogène ou infiltration.

(22:50 - 25:26)

Regardez, c'est une hypertrophie, c'est une augmentation du volume des lèvres, telle la gingivite et la gingivite inflammatoire, la gingivoragie. Donc quelle différence entre gingivite et gingivoragie ? Je commence par la gingivoragie. La gingivoragie, par inflammation, c'est un saignement, tel par exemple le scorbite, le déficit en vitamine C, tel les troubles de la coagulation.

Donc la gingivoragie, c'est une hémorragie d'origine gingivale. La gingivite, c'est une inflammation gingivale. C'est différent, surtout causée par la mauvaise hygiène dentaire.

Et là, de ce micro, je vous en prie de vous brosser correctement les dents, au moins bicotidiennement pour ne pas arriver à la gingivite et ne pas arriver à l'inflammation gingivale. Les fistules gingivales, regardez cette fistule, elles sont dues à une surinfection dentaire qui va percer le périoste et la gencive et créer une fistule, donc un orifice. Mais ça peut être aussi des tumeurs bénignes gingivales.

Donc on a vu la gingivite, nous avons vu la gingivoragie, les fistules gingivales et les tumeurs bénignes gingivales. Et la tumeur la plus connue, c'est l'épulis. Les anomalies du collet, donc nous avons des anomalies d'origine congénitale, comme la fente labiale, il y a la fente palatine.

Donc on peut avoir aussi les deux, la fente labiale et la fente palatine. Donc la fente palatine, ce qu'on appelle aussi la division palatine, c'est une communication bucconasale qui entraîne des troubles phonétiques type rhinolalie, dysfonctionnement, tubercules par otite. Donc quand le palais est fissuré et divisé en deux, il est problématique.

Il entraîne des conséquences qui sont la communication bucconasale, les troubles phonétiques et les dysfonctionnements tubercules. Là, c'est une division palatine ou fente palatine et labiale aussi, donc c'est une fente complète et c'est une anomalie congénitale. Nous arrivons à la fin du cours de sémiologie de chirurgie maxillofaciale et donc de cette série de sept cours de chirurgie maxillofaciale.

Ce que je vous demande de faire, c'est de réviser ces cours, d'être attentif à mes remarques et sur les points sur lesquels j'ai insisté durant le cours. Ce sont les éléments les plus importants et sur lesquels vous risquez d'être plus questionnés et interrogés et je vous souhaite bon courage et bonne révision.